

1. 브론패스정(한림제약(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	숙지황·목단피·오미자·천문동·황금·행인·백부근연조엑스(1.4~1.7→1)·옥수수전분혼합건조물(4.8:1) 300mg
제형 및 성상	연녹색의 타원형 필름코팅 정제
효능·효과	급성 기관지염
용법·용량	성인: 1회 1정, 1일 2회 복용
의약품 분류	229(기타의 호흡기관용약), 전문의약품
품목허가일	2021년 4월 9일

(1) 대상 질환의 특성

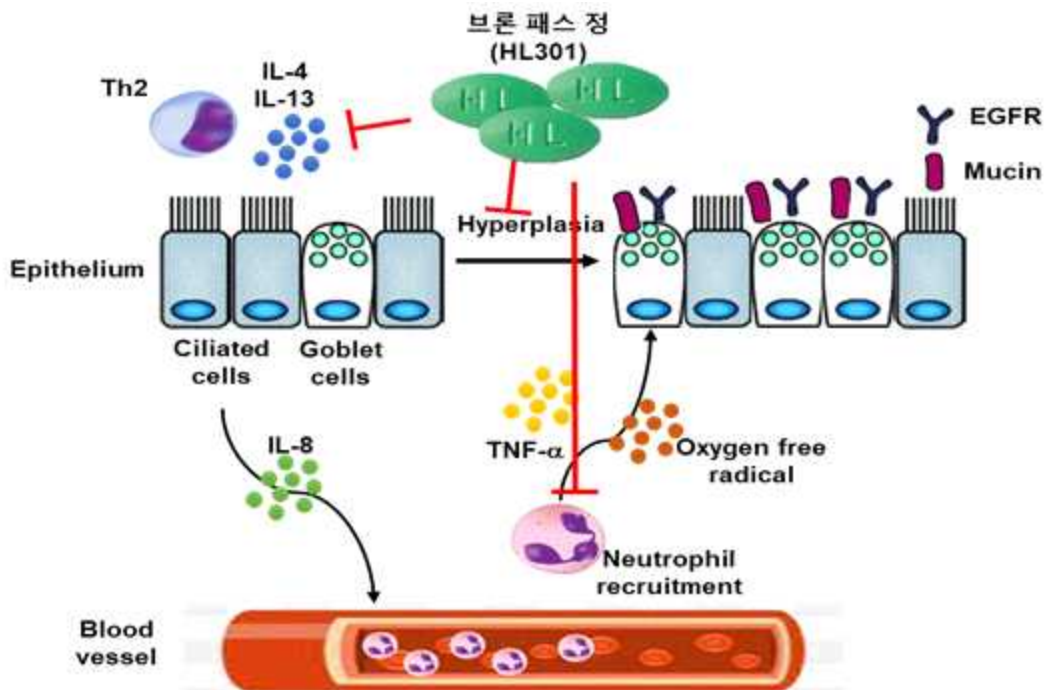
[급성 기관지염((Acute bronchitis)]¹⁾

- (정의) 급성 기관지염은 기침과 가래를 동반하는 기관 및 기관지의 염증으로 대개는 상기도 감염과 동시에 발행함. 2019년 건강보험통계연보 기준 다빈도상병 2위로 발병률이 높으며 대상 환자수가 많은 질환으로 유아, 어린이에게 발생하는 가장 흔한 호흡기계 질환으로 주로 바이러스 감염임.
- (임상양상) 주된 증상은 기침과 천명(wheezing)이다. 기침은 가래가 동반되며 20%의 환자는 이런 기침이 두 달 가까이 지속되기도 함. 대부분의 환자는 열이 동반되지 않는데, 콧물이나 인후염(sore throat)이 없으면서, 38도 이상의 발열, 100회 이상의 심박수, 24회 이상의 호흡수, 흉통이 동반된 경우에는 폐렴을 고려해야 함.
- (진단) 급성 기관지염은 임상 증상으로 진단하는 병임. 폐질환 의 과거력이 없고 폐렴을 시사하는 청진음이 없으면서 1~2주 미만의 기침을 보이는 경우는 급성 기관지염으로 진단할 수 있음. 바이러스가 주된 원인이므로 객담 도말 및 배양 검사는 도움이 되지 않음. 기저질환이 없거나 노인이 아닌 경우에는 흉부방사선 촬영이 진단에 도움이 되지 않지만, 폐렴이 의심되거나 3주 이상 기침이 지속되는 경우에는 흉부방사선 촬영을 하도록 함. 호흡곤란이나 저산소증이 동반된 환자는 맥박 산소계측(pulse oximetry)로 산소 포화도를 관찰함.
- (치료) 대증요법이 주된 치료임. 증상에 따라 진해제, 해열진통제, 항히스타민제를 처방함. 항생제가 기침하는 기간과 화농성 객담을 감소시킨다는 보고가 있지만, 최종 결과는 항생제를 사용하지 않은 환자와 크게 다르지 않고, 오히려 오심, 구토, 두통, 발진, 질염 등 항생제로 인한 부작용을 일으킴. 호흡시 천명이 들리는 환자에게는 흡입성 기관지확장제를 처방하여야 함.

1) 호흡기 응급의학. 대한응급의학회(2011). 군자출판사

(2) 약제 특성

- 신청품은 급성 기관지염에 사용되는 국내개발 천연물신약임.
- 한의서인 수세보원에 실려있는 ‘청상보하탕’의 구성 성분 18종 중 기관지염증 억제 효과가 가장 우수한 6가지 성분을 선별하고 기관지 질환에 효능이 있는 백부근을 추가한 신규 7종 복합생약추출신약임.
- 염증 부위로의 면역세포 침윤 및 활성을 억제시킴으로써 항염증 효과를 보이고 배상세포의 점액 분비를 감소시켜 진해거담 및 객담에 대한 효능을 나타낼 것으로 예상함.²⁾



2) 제약사 제출자료

(3) 교과서 및 임상진료지침

- ☐ 신청품은 국내개발 천연물신약으로 국내·외 교과서 및 임상진료지침에서 신청품을 언급하고 있지 않음.

○ 대한 결핵 및 호흡기학회

[2020 개정 기침 진료지침]

권고사항

1. 18세 미만 환자에서는 codein 성분이 호흡 억제/부전을 초래할 수 있어 기침을 억제할 목적으로 코데인 성분이 함유된 약물의 사용을 피할 것을 권고함
2. 급성 기관지염에 의한 기침에서 경험적 항생제는 화농성 객담을 동반한 경우에 한해 제한적으로 고려할 것을 권함(근거수준: 낮음, 권고수준: 강함)
3. 급성 및 아급성 기침 환자에서 기침의 호전을 위해서 베타-2 작용제를 사용하지 않을 것을 권고한다 (근거수준: 낮음, 권고수준: 강함).

4.1.2.2. 급성기관지염

상기도감염과 관련된 기침에서는 증상 완화를 위한 대증치료가 일차적인 치료이다. 서방형 슈도에페드린과 1세대 항히스타민제를 포함하는 항히스타민/총혈완화제 복합제가 대조군에 비해 기침, 후비루 및 인후불편감 개선에 효과적이며 2세대 이상의 비진정성 항히스타민제는 상대적으로 기침 감소 효과가 적었다는 보고가 있었으나, 최근 발표된 4개의 무작위 대조군 연구를 분석한 결과, 항히스타민/총혈완화제의 복합제가 기침의 중증도에 미치는 결과가 매우 상이하고 연구들이 질적으로 낮아 확실한 결론을 맺지 못하였다. 한편, 항히스타민제인 dephenhydramine은 급성 바이러스 감염으로 인한 기침환자에서 기침 민감도를 감소시키는 효과적이었다는 보고가 있다. 기침이 지속되는 경우 국소적인 알파작용제를 사용해 볼 수 있으나, 약물성 비염(rhinitis medicamentosa)을 유발할 수 있어서 추천되지 않는다. 국소적인 항콜린제가 비루나 재채기 등을 줄일 수 있으나 기침 감소에 대한 효과는 불명확하다. Rhinovirus로 인한 상기도감염에서 비스테로이드성 소염진통제인 나프록센이 두통, 무력증, 및 근육통과 함께 기침도 감소시켰다는 보고가 있으나, 아직까지는 근거가 미약함으로 기침을 완화 시킬 목적으로 비스테로이드성 진통제의 사용을 권고하지는 않는다. 18세 미만의 환자에서는 코데인 성분이 호흡 억제/부전을 초래할 수 있어 기침을 억제할 목적으로 코데인 성분이 함유된 약물의 사용을 피할 것을 권고한다. 한편, acetylcysteine 혹은 carbocysteine 은 기침의 기간을 줄이는 지는 분명하지 않다. 2주째에도 기침, 후비루, 인후불편감

등 이 지속되는 경우와 X선 검사에서 부비동 이상이 동반되는 경우에 아 급성 또는 만성기침으로 진행할 수 있다.

급성기관지염으로 인한 기침도 대증치료가 일차적인 치료이다.

급성기관지염에서 코데인이나 dextromethorphan 등의 진해제의 효과에 대한 무작위 환자-대조군 연구는 없으나, 만성기관지염에는 효과가 있으므로 단기간 동안 투여해 볼 수 있다.

거담제가 급성기관지염으로 인한 기침 완화에 효과적이라는 보고는 제한적이다.

급성기관지염의 대부분이 바이러스 감염에 의한 것이므로, 일상적으로 항생제를 처방하는 것이 권고되지는 않는다.

여러 연구에 따르면 항생제가 과도하게 처방되고, 특히 노인이나 흡연자에게 불필요한 항생제 처방이 많은 경향이 있으나, 급성기관지염으로 인한 기침에서 항생제 사용을 뒷받침하는 근거는 제한적이다.

비록 위약군에 비하여 기침 발생 빈도나 야간 기침에 도움이 되기도 하지만, 동반되는 객담의 발생 및 객담의 지속기간에는 효과가 확인되지 않았다.

급성기관지염으로 인한 기침에서 베타-2 작용제는 권고되지 않으며, 기침에 동반되는 천명음이 있는 일부 환자에서 도움이 될 수 있다.

○ NICE Guidelines(2019)³⁾

- 1.1.6 천식과 같은 호흡기 기저 질환이 있는 경우가 아니면 급성 기관지염 환자에게 경구/흡입형 기관지확장제(oral/inhaled bronchodilator, ex. salbutamol)나 경구/흡입형 코르티코스테로이드 제제(oral/inhaled corticosteroid)를 투여해서는 안됨
- 1.1.7 mucolytic(ex. acetylcysteine, carbocysteine)을 급성 기관지염으로 인한 급성 기침에 투여해서는 안됨
- 1.1.9 전신적으로 상태가 좋지 않거나 합병증의 위험이 큰 환자가 아니라면 급성 기관지염으로 인한 급성 기침 치료시 항생제를 루틴하게 처방해서는 안됨.
- 1.2.1 12세 이상에서 pelargonium, guaifenesin 등의 거담제, 진해제(codeine 성분 제외)가 기침 증상을 경감시키는데 유효하다는 제한된 증거가 있음.
- 1.2.2 항히스타민제, 비충혈제거제, codeine 포함 기침약이 기침 증상에 도움이 되지 않는다는 제한된 증거가 있음.

3) Cough (acute)_ antimicrobial prescribing (NG120). NICE guideline(2019)

○ ACCP Guidelines⁴⁾

- 4a. 급성 기관지염이 의심되는 환자에게 항생제를 이용한 일반적인 치료가 정당화되어서는 안되며, 제공되어서도 안됨.(권고등급: D)
- 6a. 베타2 작용제를 급성 기관지염을 진단받는 대다수의 환자들에게 기침 경감을 위해 루틴하게 사용하여서는 안됨.(권고등급: D)
- 6b. 기침과 함께 천명음을 동반하는 성인 환자들에서는 베타2 작용제(기관지 확장제)의 사용이 효과적일 수 있음.(권고등급: C)
- 7. 급성 기관지염 환자에게 진해제가 때때로 유용하며, 기침의 단기적 경감을 위해 투여될 수 있음. (권고등급: C)
- 8. 급성 기관지염 환자의 기침에 대하여 점액활성제(mucokinetic agent)의 일관된 효과가 없기 때문에 권고되지 않음. (권고등급: I)

○ AAFP Guidelines⁵⁾

- 1. 단순 급성 기관지염 환자에게 항생제를 처방해서는 안된다. (근거수준: A)
- 2. dextromethorphan(진해제), guaifenesin(거담제) 또는 꿀을 급성 기관지염 증상 조절 시 고려할 수 있다. (근거수준: B)
- 3. 천명음을 동반한 경우가 아니면 급성 기관지염 환자에게 베타2 작용제를 루틴하게 처방해서는 안된다. (근거수준: B)

4) Diagnosis and Management of Cough Executive Summary. ACCP Evidence-Based Clinical Practice Guidelines(2006)

5) American Academy of Family physicians(AAFP guideline, 2016)

(4) 임상시험 결과

□ 신청품의 임상문헌으로 위약대조 임상 2편 및 pelargonium sidoides 대조 임상 1편을 분석하였음.

○ [pelargonium sidoides 대조 3상연구]⁶⁾ 19~80 세의 BSS(Bronchitis Severity Score) 점수 5점 이상 급성기관지염⁷⁾ 환자를 대상으로 대조군 (pelargonium sidoides 투여군)(n=123) 대비 신청품군(n=123)의 안전성 및 유효성을 평가하고자 무작위배정, 이중맹검, 활성군 대조, 다기관, 제 3상 임상시험을 수행한 결과,

- 1차 유효성 평가지표인 기저치 대비 투약 후 2번째 방문 및 3번째 방문 시 BSS 수치 변화량 모두 신청품군과 대조군 간 유의한 차이가 없었음.(FAS⁸⁾: 신청품군 4.58 ± 1.79 vs. 대조군 4.29 ± 1.88 , $p=0.37$; PP⁹⁾: 신청품군 4.60 ± 1.81 vs. 대조군 4.33 ± 1.88 , $p=0.42$).

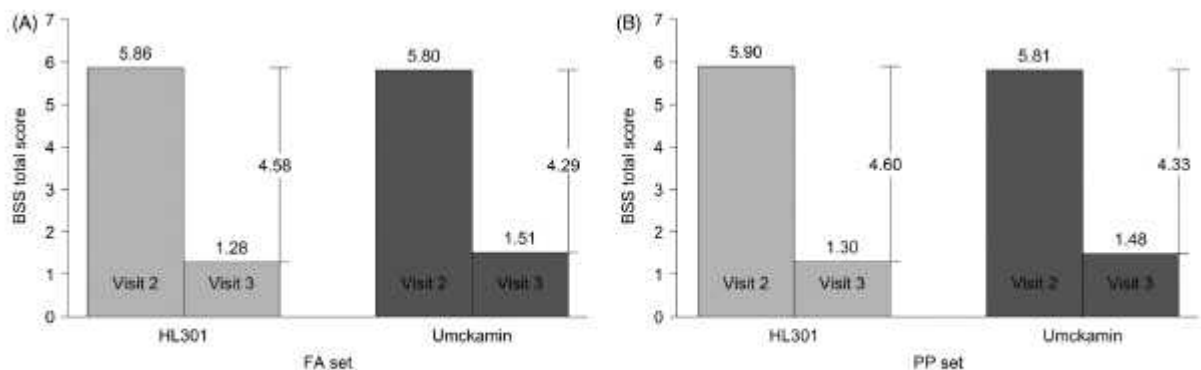


Figure 2. Difference in the bronchitis severity score (BSS) of the HL301 (light gray bar) and Umckamin (dark gray bar) groups from baseline visit (visit 2) to end of treatment visit (visit 3) in the FA set (A) and PP set (B). Abbreviations. FA set, full analysis set; PP set, per protocol set; BSS, bronchitis severity score.

- 2차 유효성 평가지표인 기저치 대비 약물 투여 후 BSS 관련 증상(기침, 가래, 호흡곤란, 흉통, 수포음) 변화량에서 두 군 간 유의한 차이는 없었음.

Table 2. Difference in each BSS component of the HL301 and Umckamin groups with treatment.

	FA set			PP set		
	HL301 (n=123)	Umckamin (n=123)	p-Value	HL301 (n=115)	Umckamin (n=120)	p-Value
Cough	1.96±0.82	1.80±0.97	.19	1.95±0.80	1.81±0.97	.30
Sputum	1.60±0.88	1.58±0.88	.92	1.60±0.90	1.58±0.88	.87
Dyspnea	0.34±0.64	0.26±0.48	.47	0.36±0.65	0.27±0.48	.43
Chest pain	0.61±0.67	0.52±0.67	.22	0.63±0.68	0.53±0.67	.15
Cackle	0.07±0.33	0.14±0.45	.37	0.06±0.33	0.14±0.45	.31

Abbreviations. FA set, full analysis set; PP set, per protocol set.

6) KIM, Won-Young, et al. HL301 versus Umckamin in the treatment of acute bronchitis: a phase III, randomized, controlled, double-blind, multicenter study. Current medical research and opinion, 2020, 36.3: 503-508.

7) 급성 기관지염: screening visit 2일 이내에 기침, 가래 또는 관련 증상 발생한 경우

8) full analysis set

9) per protocol set

- 치료반응률(response rate)¹⁰⁾은 신청품군과 대조군 간 유의한 차이가 없었음(FAS: 신청품군 86.18% vs. 대조군 77.24%, $p=0.08$; PP: 신청품군 86.09% vs. 대조군 77.50%, $p=0.09$)
- 신청품군과 대조군 간 증상 개선도¹¹⁾ 및 치료 만족도¹²⁾ 평가결과 유의한 차이가 없었음.

Table 3. Improvement and satisfaction rates at end of treatment.

	FA set			PP set		
	HL301(%)	Umckamin(%)	p-Value	HL301(%)	Umckamin(%)	p-Value
Number	123	123		115	120	
Improvement rate judged by investigators						
Improved	93 (75.5)	91 (73.9)	0.17	87 (75.6)	89 (74.2)	0.21
Not-improved	30 (24.5)	32 (26.1)		28 (24.4)	31 (25.8)	
Satisfaction rate determined by participants						
Satisfied	93 (75.5)	99 (80.4)	0.41	85 (73.9)	98 (81.6)	0.21
Not-satisfied	30 (24.5)	24 (19.6)		30 (26.1)	22 (18.4)	

Improved, "complete recovery" or "major improvement"; not-improved, "slight to moderate improvement", "no change" or "deterioration". Satisfied, "very satisfied" or "satisfied"; not-satisfied, "neutral", "dissatisfied", or "very dissatisfied".

- FAS 분석 시 이상반응은 신청품군 7명, 대조군 4명에게서 발생하였고 두 군 간 차이는 없었음.

○ [위약 대조 2b 임상연구]¹³⁾ 19~80 세의 BSS 점수 5점 이상 급성기관지염 환자를 대상으로 위약군(n=85) 대비 신청품군(n=81)의 안전성 및 유효성을 평가하고자 무작위배정, 이중맹검, 위약 대조, 다기관, 제2b상 임상시험을 수행한 결과,

- 1차 유효성 평가지표인 기저치 대비 BSS 수치 변화량은 FAS 분석 시 신청품군 4.57 ± 1.82 vs 위약군 3.15 ± 3.08 , PP 분석 시 신청품군 4.62 ± 1.81 vs 위약군 3.30 ± 3.03 으로 모두 유의한 차이를 보임 ($p < 0.001$)

10) 치료반응률은 투약 후 BSS가 3점 이하이거나, baseline 대비 투약 후 BSS가 7점 이상 감소한 경우의 비율을 의미

11) 개선도는 시험자가 평가하며, '완전히 회복됨(complete recovery)', '상당히 개선됨(major improvement)', '약간/보통 수준으로 개선됨(slight to moderate improvement)', '변화없음(no change)', '악화됨(deterioration)'의 5 단계로 나누어진다. 이 중 '완전히 회복됨'과 '상당히 개선됨'을 improved states로 정의함.

12) 만족도는 환자가 치료에 대해 '매우만족', '만족', '보통', '불만족', '매우불만족'으로 평가하며, '매우만족'과 '만족'을 만족함(Satisfied)으로 정의함

13) YOON, Sang Won, et al. HL301 in the treatment of acute bronchitis: a phase 2b, randomized, double-blind, placebocontrolled, multicenter study. The Korean journal of internal medicine, 2020, 35.1: 133.

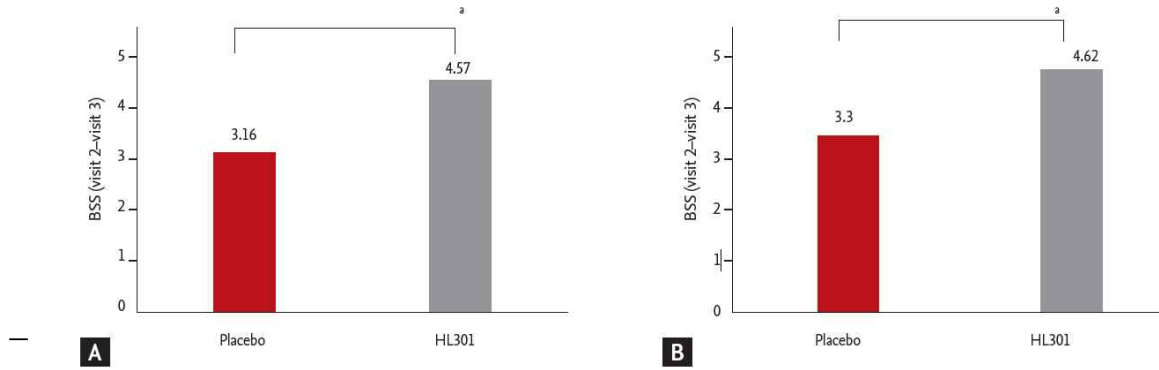


Figure 2. The difference in bronchitis severity score (BSS) from baseline visit (visit 2) to the end of treatment visit (visit 3). (A) The full analysis set and (B) the per protocol set. ^a $p < 0.001$.

- 2차 유효성 평가지표인 기저치 대비 약물 투여 후 BSS 관련 증상(기침, 가래, 호흡곤란, 흉통, 수포음) 변화량에서 두 군 간 모두 유의한 차이를 보임

Table 2. Difference in each component of the bronchitis severity score between baseline visit (visit 2) and the end of treatment (visit 3) in the placebo and HL301 groups

Variable	FAS			PPS		
	Placebo (n = 85)	HL301 (n = 81)	p value	Placebo (n = 80)	HL301 (n = 79)	p value
Cough	1.37 ± 1.29	1.77 ± 0.88	0.0253	1.39 ± 1.25	1.77 ± 0.89	0.0496
Sputum	1.02 ± 1.20	1.58 ± 1.06	0.0017	1.09 ± 1.20	1.61 ± 1.06	0.0037
Dyspnea	0.09 ± 0.50	0.31 ± 0.52	0.0038	0.10 ± 0.49	0.32 ± 0.52	0.0038
Chest pain	0.47 ± 0.77	0.79 ± 0.63	0.0005	0.48 ± 0.76	0.80 ± 0.63	0.0007
Crackle	0.25 ± 0.53	0.12 ± 0.37	0.0402	0.25 ± 0.54	0.13 ± 0.37	0.0470

Values are presented as mean ± SD.

FAS, full analysis set; PPS, per protocol set.

- 치료반응률(response rate)은 신청품군과 대조군 간 유의한 차이를 보임(FAS: 신청품군 82.72% vs. 대조군 58.82%, $p < 0.001$; PP: 신청품군 84.81% vs. 대조군 61.25%, $p < 0.001$)
- 안전성 관련, 전체 이상반응 발생은 FAS 분석 시, 위약군 4명, 신청품군 1명에게 발생하였으며 군 간 차이는 없었음.

○ [위약 대조 2상 임상연구]¹⁴⁾ 19~80 세의 BSS 점수 5점 이상 만성기관지염¹⁵⁾ 및 급성기관지염 환자를 대상으로 위약군(n=38) 대비 신청품군¹⁶⁾의 안전성 및 유효성을 평가하고자 무작위배정, 이중맹검, 위약 대조, 다기관, 제 2상 임상시험을 수행한 결과,

- 1차 유효성 평가지표인 기저치 대비 BSS 수치 변화량은 FAS 분석, PP 분석 결과 모두 위약군 대비 신청품군 모두에서 유의한 차이를 보임(PP 분석 시 신청품 0.6 g/day군 4.63 ± 2.24 vs 위약군 2.88 ± 2.57 , $p=0.012$; 신청품 1.2 g/day군 4.08 ± 1.63 vs 위약군 2.88 ± 2.57 $p=0.011$; 1.8 g/day군 4.15 ± 1.74 vs 위약군 2.88 ± 2.57 $p=0.013$)

Table 3. Difference in total BSS at baseline visit (visit 2) and end of treatment (visit 3) in placebo group and the three treatment groups.

	Placebo	HL301 0.6g/day	HL301 1.2g/day	HL301 1.8g/day
FA set				
Number	37	39	43	39
BSS change with Tx (mean $\pm$ SD)	3.11 ± 2.75	4.44 ± 2.20	4.09 ± 1.56	4.18 ± 1.73
Median	3.00	4.00	4.00	4.00
Min, max	-3.00, 11.00	-1.00, 10.00	0.00, 9.00	0.00, 7.00
Lower margin of confidence	—	0.19	0.02	0.04
Superiority margin	—	0	0	0
PP set				
Number	34	35	39	34
BSS change with Tx (mean $\pm$ SD)	2.88 ± 2.57	4.63 ± 2.24	4.08 ± 1.63	4.15 ± 1.74
Median	3.00	5.00	4.00	4.00
Min, Max	-3.00, 11.00	-1.00, 10.00	0.00, 9.00	0.00, 7.00
Lower margin of confidence	—	0.57	0.20	0.22
Superiority margin	—	0	0	0

Tx: treatment.

- 2차 유효성 평가지표인 Percentage BSS systemic sign efficacy¹⁷⁾은 위약군 대비 신청품군 모두에서 유의한 개선을 보임.

14) PARK, Myung Jae, et al. Efficacy and safety of HL301 in the treatment of acute bronchitis and acute exacerbation of chronic bronchitis: a phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study. Current medical research and opinion, 2017, 33.5: 919-925.

15) 만성 기관지염: 2년간 연속으로 1년에 3개월 이상 기침과 가래가 나오는 상태

- 만성 기관지염의 급성 악화(acute exacerbation of chronic bronchitis, AECB): 만성 기관지염 환자에서 호흡곤란 및 관련 호흡기 증상이 2일 이상 발생하는 경우

16) HL301(브론패스정)0.6g/일(n=40), HL301(브론패스정)1.2g/일(n=43), HL301(브론패스정)1.8g/일(n=39)

17) BSS systemic sign efficacy, 치료 후 BSS가 최소 30% 이상 개선된 환자의 비율

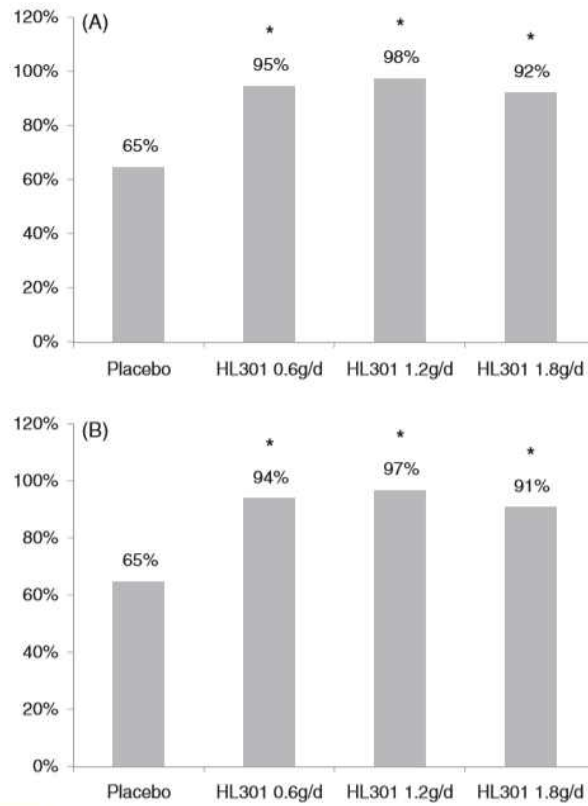


Figure 3. Percentage BSS systemic sign efficacy after treatment (percentage of participants whose BSS improved at least 30% after treatment). (A) FAS (full analysis set) and (B) PPS (per protocol set). * $P < .05$.

- 기저치 대비 약물 투여 후 BSS 관련 증상(기침, 가래, 호흡곤란, 흉통, 수포음) 변화량에서는 기침에서만 유의한 차이를 보임.

(5) 학회의견

- 관련 학회¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾에서는 기존 급성 기관지염 치료제와의 비교한 임상문헌을 근거로 기존 약제와 효과, 안전성 면에선 동일하면서도 성인을 위한 복용편의성이 개선된 약제며 생약 유래 약제 이외의 케미칼 성분의 진해거담제까지 대체하여 사용할 수 있고, 별도의 투여 단계 없이 기존 치료 약제와 병용하여 처방 가능하다는 의견임.

(6) 진료상 필수여부

- 신청품은 "급성 기관지염"로 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 acetylcysteine, L-carbocysteine, erdosteine, methyl-N,S-diacetylcysteine, ambroxol, benzonatate, bromhexine, ivy leaf 추출물 약제, sobrerol, levodropropizine, pelargonium sidoides 포함 약제, coptis rhizome 포함약제 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

- 약제 급여기준 소위원회(약제급여기준소위원회, 2021년 6월 30일)

구분	세부인정기준 및 방법
[일반원칙] 진해거담제	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 영양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 경구 진해거담제는 약제의 성분, 약리작용 및 효능·효과, 환자의 증상 에 따라 선별적으로 투여함을 원칙으로 하며, 나. 상기도 질환에 시럽제를 포함하여 2종 이내, 그 이외의 호흡기질환 (천식 및 만성폐쇄성폐질환 제외)에는 시럽제를 포함하여 3종 이내로

18) 대한결핵 및 호흡기학회()

19) 대한이비인후과학회()

20) 대한천식알레르기학회()

	인정함. 다. 만6세 미만 소아의 경우에는 함량 및 성분 등이 과량 또는 중복되지 아니하는 범위 내에서 복합시럽제 1종을 추가로 인정함. 라. 식품의약품안전처장이 정한 의약품분류번호 222, 229에 해당되는 약제라도 약리작용이 진해, 거담, 기관지확장이 아닌 약제는 적용되지 아니함. 마. 진해거담 주사제는 신속한 치료효과가 필요한 경우에 인정함.
--	---

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 국내 개발 신약으로, 제외국 허가 및 약가집 수재 현황 없음.